DÉVELOPPEMENT D'UN INHIBITEUR ACQUIS DU FACTEUR XI AU COURS D'UNE LEUCÉMIE MYÉLOMONOCYTAIRE CHRONIQUE (LMMC) : A PROPOS D'UN CAS

Y.O. DJEGHRI [1], I. HOUAR [1] , Y. BOUFLOUGHA [1], K. BOUZENDA [1].
[1] Centre d'hémobiologie et transfusion sanguine (CHTS), CHU Constantine, Algérie
Email : Djeghriyara@gmail.com

1er CONGRÈS INTERNATIONAL DE BIOLOGIE MÉDICALE DE SÉTIF
24-25 OCTOBRE 2026

Introduction

La LMMC est une hémopathie maligne appartenant au groupe des néoplasies myélodysplasiques/myéloprolifératives, dont les complications incluent des manifestations hémorragiques et auto-immunes, parmi lesquelles le développement d'un anticoagulant circulant acquis (ACC) reste exceptionnel mais possible.

Objectif

Rapporter un cas de LMMC compliquée par un inhibiteur acquis anti-FXI associé à une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), afin de sensibiliser à ces complications rares en soulignant la démarche diagnostique et la prise en charge thérapeutique.

Observation

-Patient âgé de 64 ans, suivi initialement pour un SMD de forme hypoplasique diagnostiqué en 2023, puis perdu de vue.
-Réadmission au service d'hématologie en 2025 pour altération de l'état général.
-Le bilan biologique initial retrouve :
- **Anémie** : Hb = 8 g/dL ; **Thrombopénie sévère** 60G/L ; **Monocytose persistante**.
- TP à 56 %, avec test de Koller negatif.

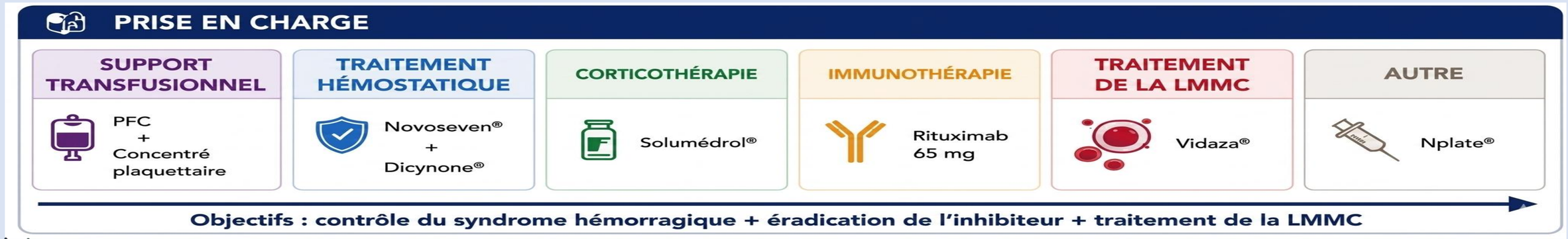
-L'exploration hématologique, incluant la cytométrie en flux, permet de retenir le diagnostic de LMMC.
-L'évolution est marquée par l'apparition d'un syndrome hémorragique diffus, persistant malgré le support transfusionnel par PFC et concentrés plaquettaires.
-L'interrogatoire ne retrouve aucun antécédent hémorragique personnel ou familial.



-L'exploration biologique hémostatique montre:
- Une diminution progressive du taux de fibrinogène, des plaquettes et du TP.
- Le dosage des D-dimères n'a pas pu être réalisé en raison de l'indisponibilité du réactif.
- L'allongement du TCA associé à un indice de Rosner positif (IR) oriente vers la présence d'un inhibiteur circulant acquis.
- Le dosage des facteurs de la voie intrinsèque met en évidence un déficit en FXI.
- La présence d'un inhibiteur anti-FXI est confirmée avec un titre de 1,4 UB.

-La cinétique biologique consommatrice est compatible avec une CIVD associée.

	TP	Ratio TCA	Fg (g/l)	Test de correction du TP	IR	FVIIIc	FVW:Ag	FIX	FXI
1er prélèvement	34%	1,21	1,02	/	21%	61%	75%	68%	**31%**
2 ème prélèvement	30%	1,19	0,98	59%	25%	89%	90%	73%	**28%**



Discussion

- ✓ L'association d'un inhibiteur acquis anti-FXI et d'une CIVD au cours d'une LMMC est exceptionnelle.
- ✓ Un cas similaire a été rapporté par Billon et al., suggérant un rôle de la dysrégulation immunitaire liée à la LMMC dans l'apparition d'auto-anticorps dirigés contre les facteurs de coagulation.
- ✓ Cependant Il existe une faible corrélation entre le taux circulant de FXI et la sévérité du syndrome hémorragique, la coexistence d'une CIVD responsable d'une consommation accrue des facteurs de coagulation et des plaquettes, explique la gravité du tableau hémorragique observé chez notre patient.

Conclusion

Ce cas souligne l'intérêt d'évoquer un inhibiteur spécifique devant des troubles de l'hémostase réfractaires aux transfusions chez un patient atteint de LMMC.
La reconnaissance précoce de cette complication rare conditionne l'instauration rapide d'un traitement hémostatique et immunosuppresseur adapté.

Références bibliographiques

1/ Billon S, Blouch MT, Escoffre-Barbe M, Le Niger C, Le Roux AM, Abgrall JF. A case of chronic myelomonocytic leukaemia and factor XI deficiency with a circulating anticoagulant. *Haemophilia*. 2001;7(4):433-6. doi:10.1046/j.1365-2516.2001.00523.x
2/ Jachiet V, Hadjadj J, Zhao LP, Chasset F, Fain O, Fenaux P, et al. Manifestations dysimmunitaires associées aux syndromes myélodysplasiques et leucémies myélomonocytaires chroniques. *Bull Cancer*. 2023;110(11):1147-55. doi:10.1016/j.bulcan.2023.02.023.
3/ Barg AA, Livnat T, Kenet G. Factor XI deficiency: phenotypic age-related considerations and clinical approach towards bleeding risk assessment. *Blood*. 2024;143(15):1455-64. doi:10.1182/blood.2023020721.